



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
KHOA ĐIỀU DƯỠNG - HỘ SINH

📖 Tiểu luận tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng · hệ vừa làm vừa học

Khảo sát kiến thức và thái độ về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B của khách hàng đến khám tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ năm 2026

👥 70
khách hàng tham gia

☰ 20 + 15
câu kiến thức · thái độ

📅 08/2026
thu thập số liệu

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Thị Phương Huy

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Hoài Nhi

LỚP · KHÓA

TC23B2 · 2024 – 2026



Nội dung trình bày

01

Đặt vấn đề

Gánh nặng viêm gan B · khoảng trống nghiên cứu · mục tiêu



02

Tổng quan tài liệu

Khung nghiên cứu · HBV lây qua đâu?



03

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Thiết kế cắt ngang · bộ câu hỏi · tiêu chí đánh giá · xử lý số liệu



04

Kết quả và bàn luận

Đặc điểm chung · kiến thức · thái độ · yếu tố liên quan · bàn luận



05

Kết luận và khuyến nghị

Thực trạng · bản đồ yếu tố liên quan · khuyến nghị



Slide dự phòng cho phần hỏi – đáp

Khái niệm · y văn · địa bàn · xử lý số liệu · bảng 3.8 – 3.10 đầy đủ



NGHIÊN CỨU TRONG MỘT CÂU

Mô tả **kiến thức**, **thái độ** về tiêm vaccine phòng viêm gan B và tìm **yếu tố liên quan** ở khách hàng của một phòng khám tư nhân đô thị.

70

khách hàng ≥ 18 tuổi
hoàn thành bảng hỏi

$p < 0,05$

ngưỡng ý nghĩa thống kê ·
 χ^2 / Fisher's exact



Slide có **tương tác**: di chuột để xem số liệu chi tiết, nhấn vào thẻ để lật, nhấn  để hiện từng ý.

01

PHẦN MỘT

Đặt vấn đề



Gánh nặng viêm gan B

Khoảng trống nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

01
Đặt vấn đề

02
Tổng quan tài liệu

03
Đối tượng & phương pháp

04
Kết quả & bàn luận

05
Kết luận & khuyến nghị

+
Dự phòng



01 ĐẶT VẤN ĐỀ

Viêm gan B – gánh nặng y tế công cộng lớn



240 triệu

người nhiễm HBV mạn tính trên toàn cầu



0,9 triệu

ca mắc mới mỗi năm



~1,1 triệu

tử vong/năm, chủ yếu do xơ gan, ung thư gan



8–10%

tỷ lệ nhiễm mạn tại Việt Nam – vùng dịch tễ cao



GIẢI PHÁP

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động, an toàn và hiệu quả nhất – được **WHO** và **Bộ Y tế** khuyến cáo cho tất cả, đặc biệt trẻ sơ sinh, trẻ em và người trẻ khỏe mạnh.



Nhưng vẫn còn rào cản

Kiến thức **chưa đầy đủ** và sự **do dự vaccine** (vaccine hesitancy) khiến tỷ lệ tiêm chủng ở **người trưởng thành** chưa cao – nhiều khách hàng vẫn mơ hồ về chỉ định, lịch tiêm và tính an toàn.

Nguồn: WHO 2024; Bộ Y tế; Ho NH & cs 2026; Kim TV & cs 2024.



Nhận thức về HBV còn hạn chế – và một khoảng trống



Thế giới

24%

Pakistan – sinh viên y hiểu đúng về dự phòng sau phơi nhiễm

52%

Ethiopia – thai phụ biết về lây truyền mẹ – con

46,1%

Ghana – hiểu sai đường lây; 29,6% kiến thức kém



Việt Nam

Quách Thị Cần, Nguyen VTT, Nguyen VT & cs: tỷ lệ hiểu đúng về **lịch tiêm, liều tiêm, hiệu quả vaccine** còn thấp.

Nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung vào:

Khu vực nông thôn

Phụ nữ mang thai, bà mẹ

Nhân viên y tế

Kiến thức, thái độ chịu tác động bởi **học vấn, tuổi, giới, thu nhập, tiền sử gia đình, tiếp cận thông tin, chi phí**.



Khách hàng y tế tư nhân

Hệ thống ngoài công lập ngày càng quan trọng trong cung ứng tiêm chủng, nhưng dữ liệu trên nhóm khách hàng này **còn hạn chế**.

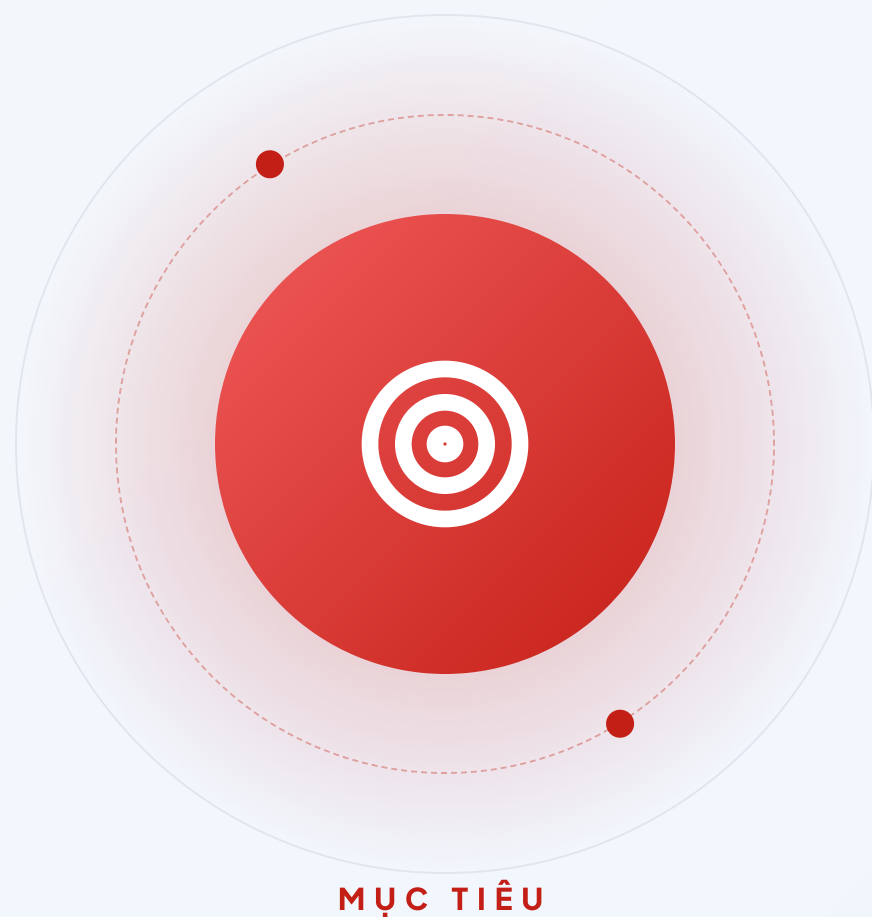
Tại **PKĐK MEDLATEC Tây Hồ**, thực tế lâm sàng cho thấy nhiều khách hàng vẫn mơ hồ về **chỉ định, lịch tiêm và tính an toàn** của vaccine.

→ Cần khảo sát để có cơ sở tư vấn trúng đích



01 ĐẶT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu



Mục tiêu mô tả

1

Mô tả kiến thức và thái độ về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B của khách hàng đến khám tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ năm 2026.

KẾT QUẢ

Kiến thức

3 điểm nhấn

Thái độ

Thái độ – hành động

Kết luận 1

Mục tiêu phân tích

2

Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ về tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B của nhóm khách hàng này.

KẾT QUẢ

Yếu tố – kiến thức

Yếu tố – thái độ

Bản đồ yếu tố

👤 N = 70 khách hàng

📅 01 – 31/08/2026

📍 Trung tâm Tiêm chủng – PKĐK MEDLATEC Tây Hồ

02

PHẦN HAI

Tổng quan tài liệu



Khung nghiên cứu

HBV lây qua đâu?

Khái niệm nền tảng · dự phòng

Yếu tố theo y văn · dự phòng

Địa bàn · dự phòng

01
Đặt vấn đề

02
Tổng quan tài liệu

03
Đối tượng & phương pháp

04
Kết quả & bàn luận

05
Kết luận & khuyến nghị

+
Dự phòng



Khung nghiên cứu

Đặc điểm nhân khẩu học

Trình độ học vấn
Nghề nghiệp
Thu nhập
Tình trạng hôn nhân
Tuổi
Giới tính

K	A
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Tiền sử & tiếp cận thông tin

Được NVYT tư vấn vaccine
Tiền sử tiêm vaccine
Người thân mắc HBV
Từng nghe/tìm hiểu HBV
Từng xét nghiệm HBV
Nguồn tin người thân/bạn bè

K	A
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

CHI-SQUARE ·
FISHER'S EXACT

$P < 0,05$

Mô tả cắt ngang
có phân tích

BIẾN PHỤ THUỘC 1 · K

Kiến thức

20 câu Đúng/Sai/Không biết · 0–20 điểm
Đạt ≥ 16 điểm ($\geq 80\%$)

BIẾN PHỤ THUỘC 2 · A

Thái độ

15 câu Likert 5 mức · 15–75 điểm
Tích cực ≥ 60 điểm ($\geq 80\%$)



HBV lây qua đâu – và không lây qua đâu?

CÓ LÂY

Đường lây chủ yếu của HBV (WHO, Bộ Y tế).

KT3 · 78,6% khách hàng trả lời đúng

CÓ LÂY

Lây qua dịch sinh dục khi không có biện pháp bảo vệ.

KT4 · 62,9% trả lời đúng · 30,0% không biết

CÓ LÂY

Lây truyền chu sinh – nguyên nhân chính của viêm gan mạn tại Việt Nam.

KT5 · chỉ 52,9% trả lời đúng · 40,0% không biết

KHÔNG LÂY

HBV không lây qua tiếp xúc thông thường.

KT6 · chỉ 38,6% bác bỏ đúng nhận định sai

KHÔNG LÂY

Nhầm với vi rút đường tiêu hóa là căn nguyên của kỳ thị người bệnh.

KT6 · 61,4% trả lời sai hoặc không biết

KHÔNG LÂY

Hiểu đúng điều này giúp giảm kỳ thị và sống chung an toàn với người bệnh.

Nguồn: WHO 2024; Bộ Y tế 2019

03

PHẦN BA

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu



Thiết kế & đối tượng

Bộ câu hỏi, tiêu chí & xử lý số liệu

Xử lý số liệu & đạo đức · dự phòng

01
Đặt vấn đề

02
Tổng quan tài liệu

03
Đối tượng & phương pháp

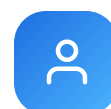
04
Kết quả & bàn luận

05
Kết luận & khuyến nghị

+
Dự phòng

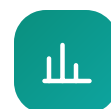


Đối tượng, địa điểm, thời gian và thiết kế



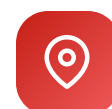
Đối tượng

Khách hàng ≥ 18 tuổi đến khám/dùng dịch vụ tại TTTC – PKĐK MEDLATEC Tây Hồ, đồng ý tham gia



Thiết kế

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích



Địa điểm

Trung tâm Tiêm chủng – Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ, Hệ thống Y tế MEDLATEC



Chọn mẫu

Thuận tiện liên tiếp
(consecutive convenience sampling) – mời tất cả khách hàng đủ điều kiện trong thời gian thu thập

CỖ MẪU THỰC TẾ

70

khách hàng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và **hoàn thành bảng hỏi**

Chọn mẫu thuận tiện $\rightarrow$ không tính cỡ mẫu theo công thức.



✓ Tiêu chuẩn lựa chọn × Loại trừ

- Từ đủ 18 tuổi trở lên
- Đến khám/dùng dịch vụ tại TTTC trong thời gian NC
- Giao tiếp được bằng tiếng Việt
- Đồng ý tham gia sau khi được giải thích



Bộ câu hỏi và tiêu chí đánh giá

A 12 câu Thông tin chung

Nhân khẩu học, tiền sử tìm hiểu – tư vấn – xét nghiệm – tiêm vaccine, gia đình mắc HBV, nguồn thông tin.

B 20 câu Kiến thức

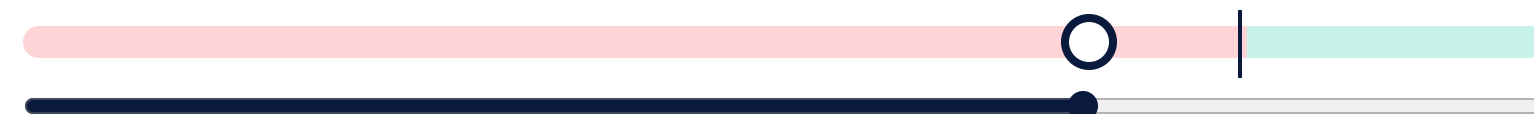
Đúng / Sai / Không biết. Đúng = **1 điểm**; sai hoặc không biết = 0 điểm. Tổng 0–20 điểm.

C 15 câu Thái độ · Likert 5 mức



Kiến thức (0 – 20 điểm)

Đạt ≥ 16 điểm ($\geq 80\%$)
Điểm cắt 16



Điểm: **14/20** · 70,0% tổng điểm

X CHƯA ĐẠT

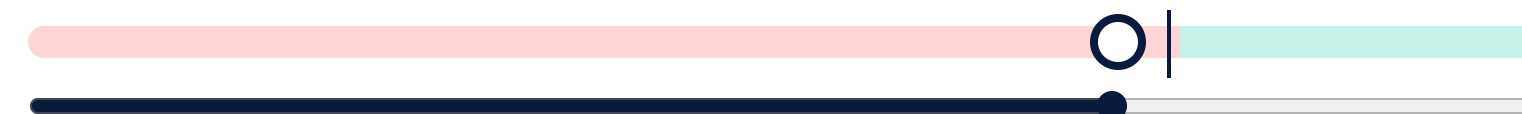
Kéo thanh trượt để xem cách phân loại. Điểm trung bình thực tế của mẫu: 14,34.

Kết quả: 36/70 đạt · 51,4%

34 chưa đạt · 48,6%

Thái độ (15 – 75 điểm)

Tích cực ≥ 60 điểm ($\geq 80\%$)
Điểm cắt 60



Điểm: **58/75** · 77,3% tổng điểm

X CHƯA TÍCH CỰC

Tổng điểm 15 câu Likert (1–5). Tích cực khi đạt từ 80% tổng điểm trở lên.

Kết quả: 39/70 tích cực · 55,7%

31 chưa tích cực · 44,3%



Làm sạch, mã hóa

→ Excel 2019

→ SPSS 26.0

→ χ^2 / Fisher's exact · $p < 0,05$

🔒 Đạo đức: được Trường & PKĐK chấp thuận · tự nguyện · bảo mật

04

PHẦN BỐN

Kết quả và bàn luận



Đặc điểm chung

Kiến thức

Thái độ

Yếu tố liên quan

Bàn luận & hạn chế

01
Đặt vấn đề

02
Tổng quan tài liệu

03
Đối tượng & phương pháp

04
Kết quả & bàn luận

05
Kết luận & khuyến nghị

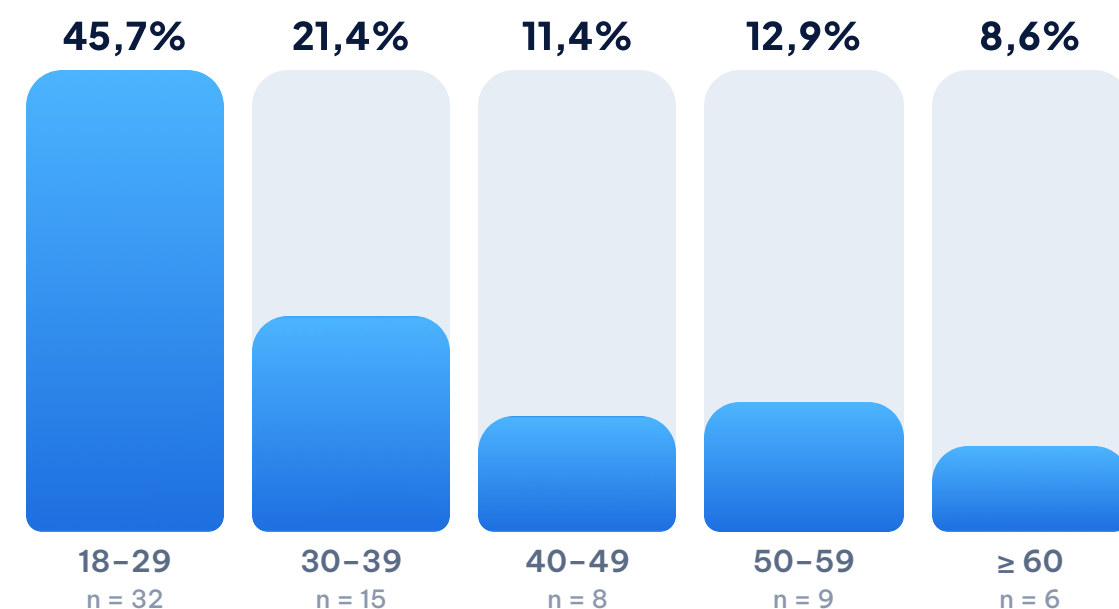
+
Dự phòng



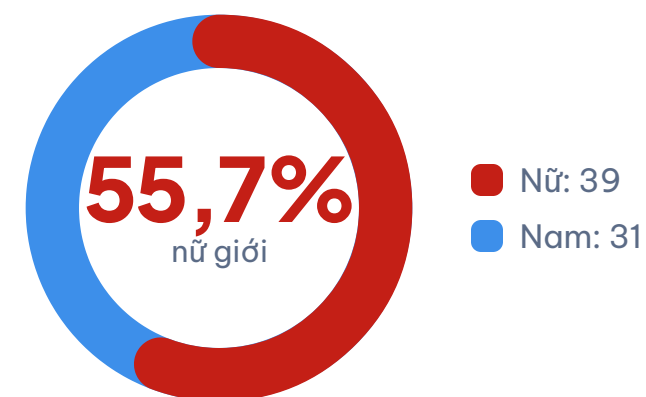
Đối tượng trẻ, nữ nhiều hơn, học vấn khá cao

Nhóm tuổi

TB 33,33 ± 13,10

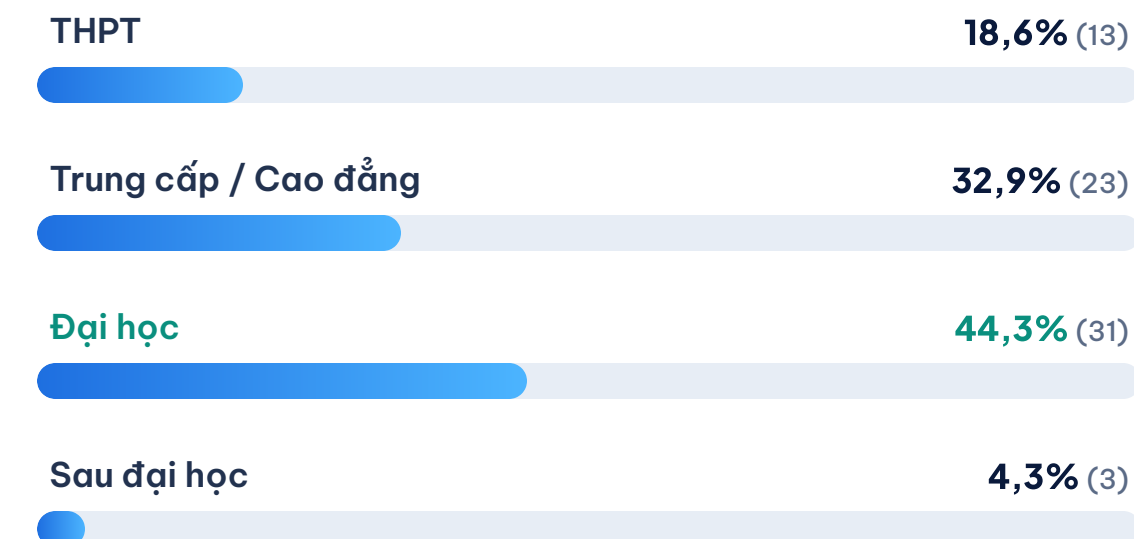


Giới tính

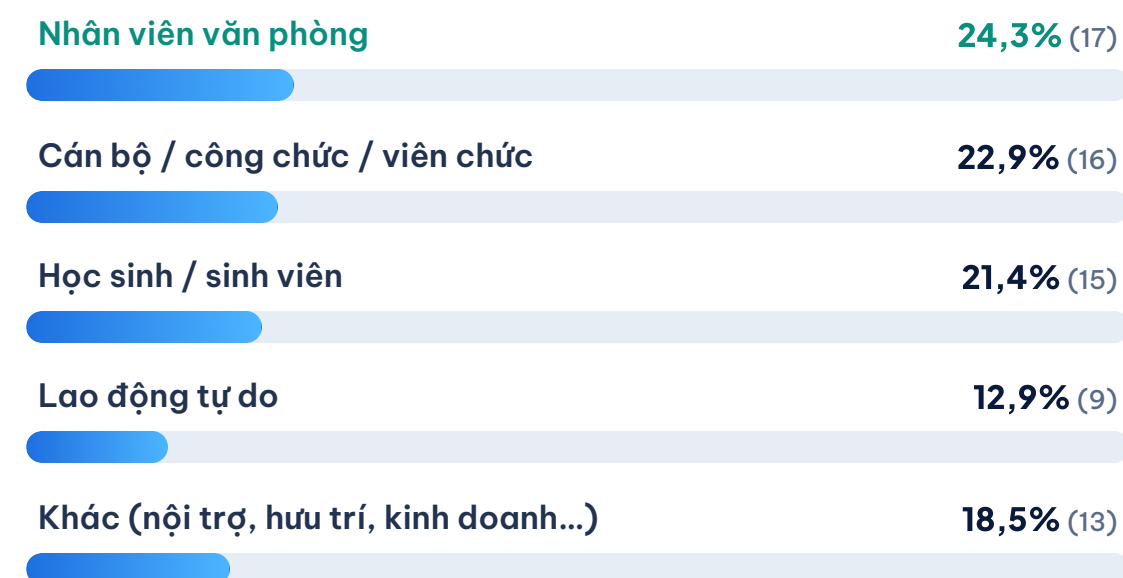


Trình độ học vấn

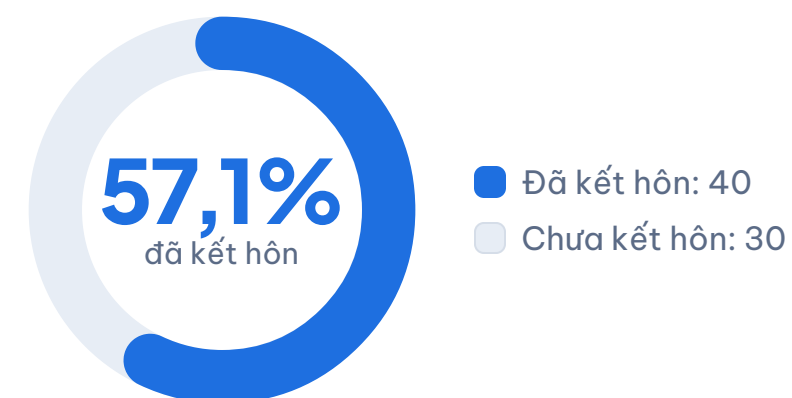
81,5% ≥ trung cấp



Nghề nghiệp

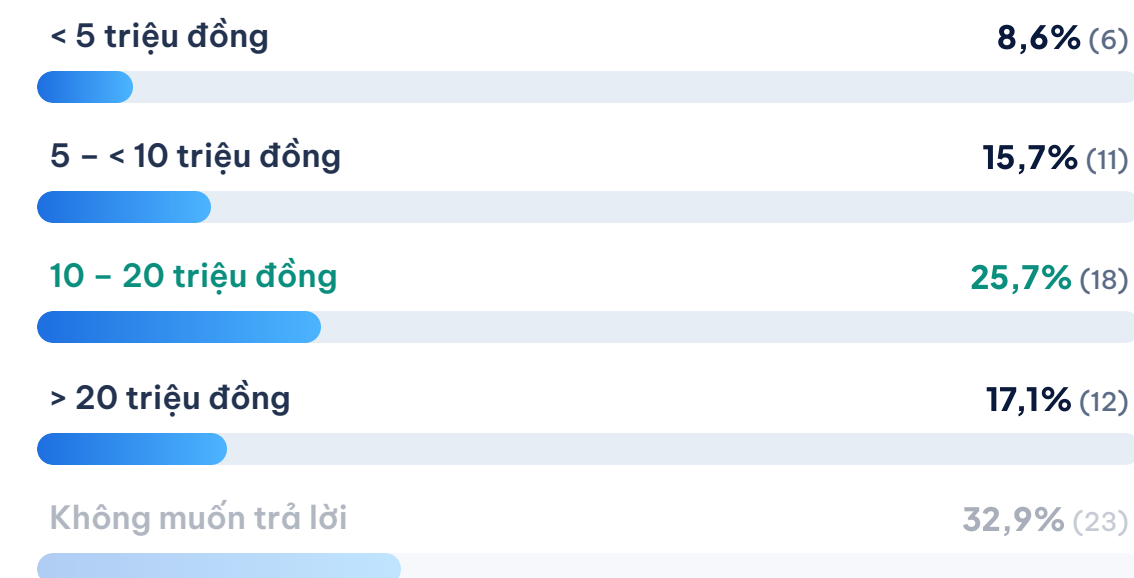


Tình trạng hôn nhân



Thu nhập / tháng

⚠ 32,9% không trả lời





Biết đến bệnh nhiều – nhưng tiêm đủ mũi còn ít

Từng nghe / tìm hiểu về VGB



Được tư vấn tiêm vaccine VGB



Từng xét nghiệm VGB



Tiền sử tiêm vaccine VGB



Gia đình / người thân mắc VGB



■ Đã từng / Có / Tiêm đủ mũi ■ Đã tiêm chưa đủ mũi ■ Chưa từng / Không ■ Không nhớ / Không biết

70,0%

đã từng nghe/tìm hiểu về viêm gan B

47,1%

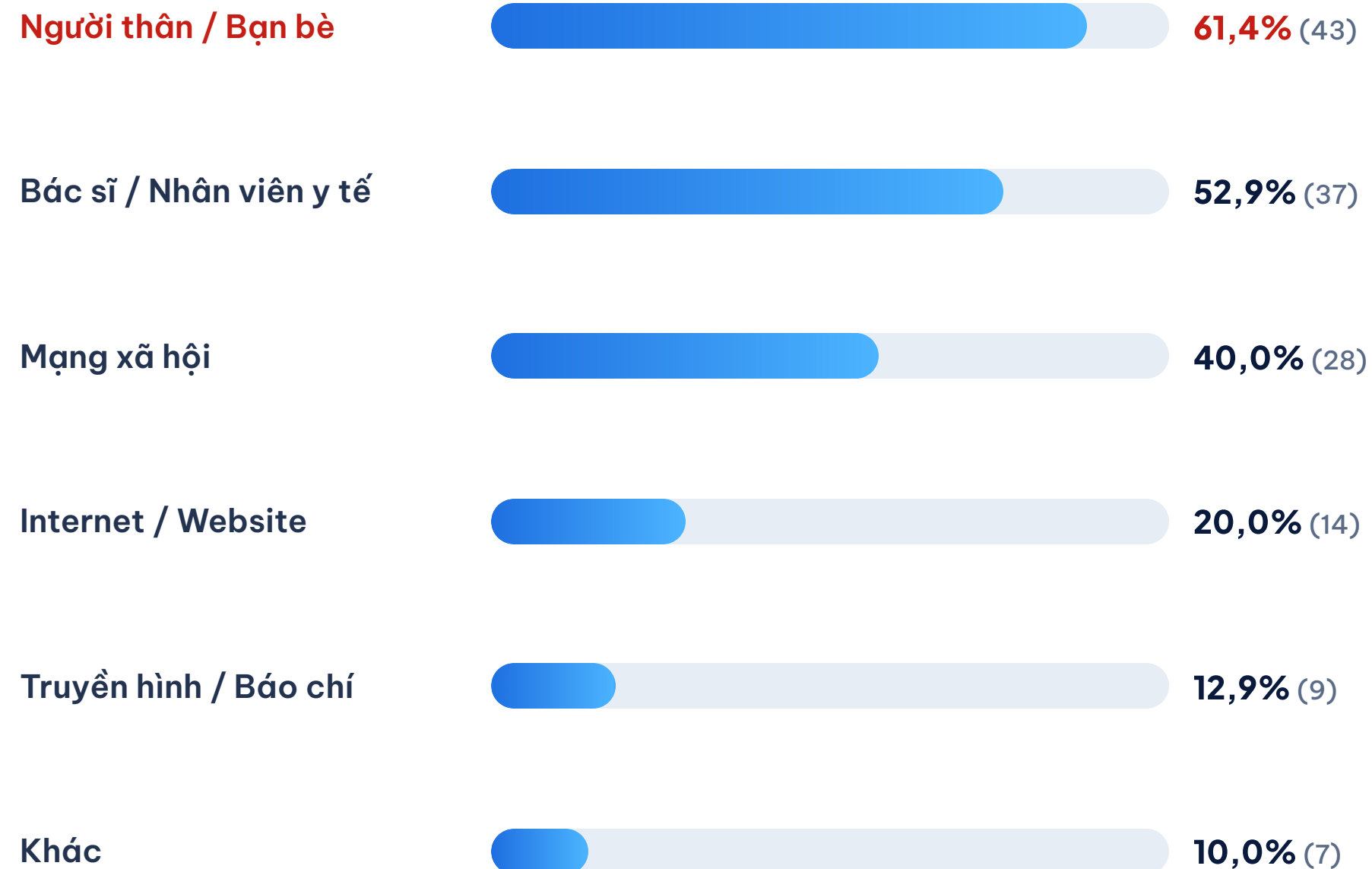
từng được tư vấn vaccine – cũng là tỷ lệ từng xét nghiệm HBV

BÀN LUẬN

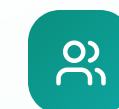
Chỉ **25,7%** tiêm đủ mũi, **48,6%** chưa từng tiêm: nhận thức **chưa chuyển thành hành vi** – trùng cảnh báo của Kim TV (2024) về thiếu tư vấn trực tiếp.



Người thân, bạn bè là nguồn tin phổ biến nhất



Đối tượng có thể chọn nhiều hơn một nguồn thông tin (N = 70).



Vai trò trụ cột của NVYT

52,9% tiếp cận qua bác sĩ/nhân viên y tế – tương đồng Le Nguyen AT & cs (2019).



Rủi ro “truyền miệng”

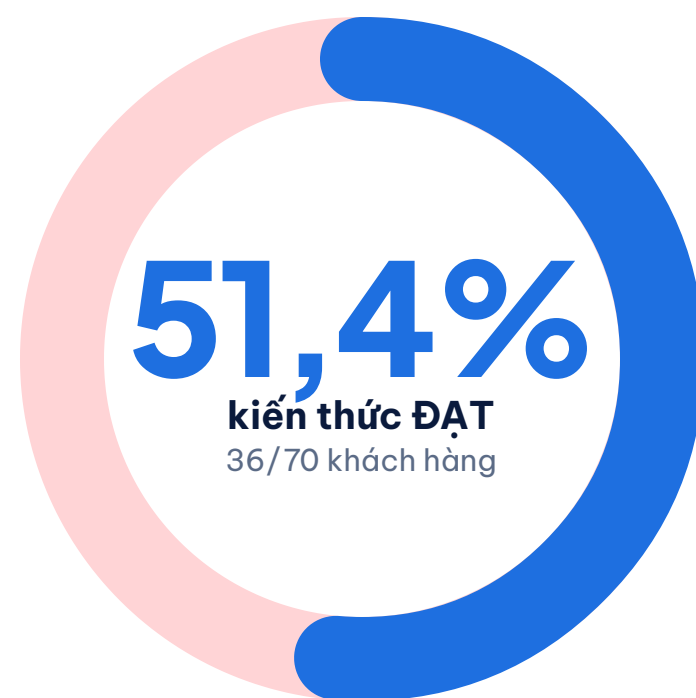
Hơn 60% nhận tin qua mạng lưới thân cận (Chu JN 2017) – tiềm ẩn thông tin sai lệch.

Tỷ lệ kiến thức đạt **thấp hơn** ở nhóm nhận tin từ người thân ($p = 0,043$):





Chỉ hơn một nửa khách hàng có kiến thức đạt



Đạt (≥ 16): 36 · 51,4% Chưa đạt: 34 · 48,6%

Điểm trung bình



Khoảng điểm

2 – 20
Min – Max

Tỷ lệ kiến thức đạt/tốt so với y văn

MEDLATEC Tây Hồ (2026) – kiến thức đạt 51,4% (36/70)



Rajamoorthy, Malaysia (2019) – kiến thức tốt 36,9% (–)



Quách Thị Cần, Quảng Bình (2017): tỷ lệ tương đương.
Adjei CA (Ghana 2022): 29,6% kiến thức kém – thang đo khác, chỉ tham khảo.

BÀN LUẬN

Tương đương **Quách Thị Cần** (2017, Quảng Bình); cao hơn **Rajamoorthy** (2019, Malaysia) và **Adjei** (2022, Ghana) – do mặt bằng **học vấn đô thị** cao hơn.

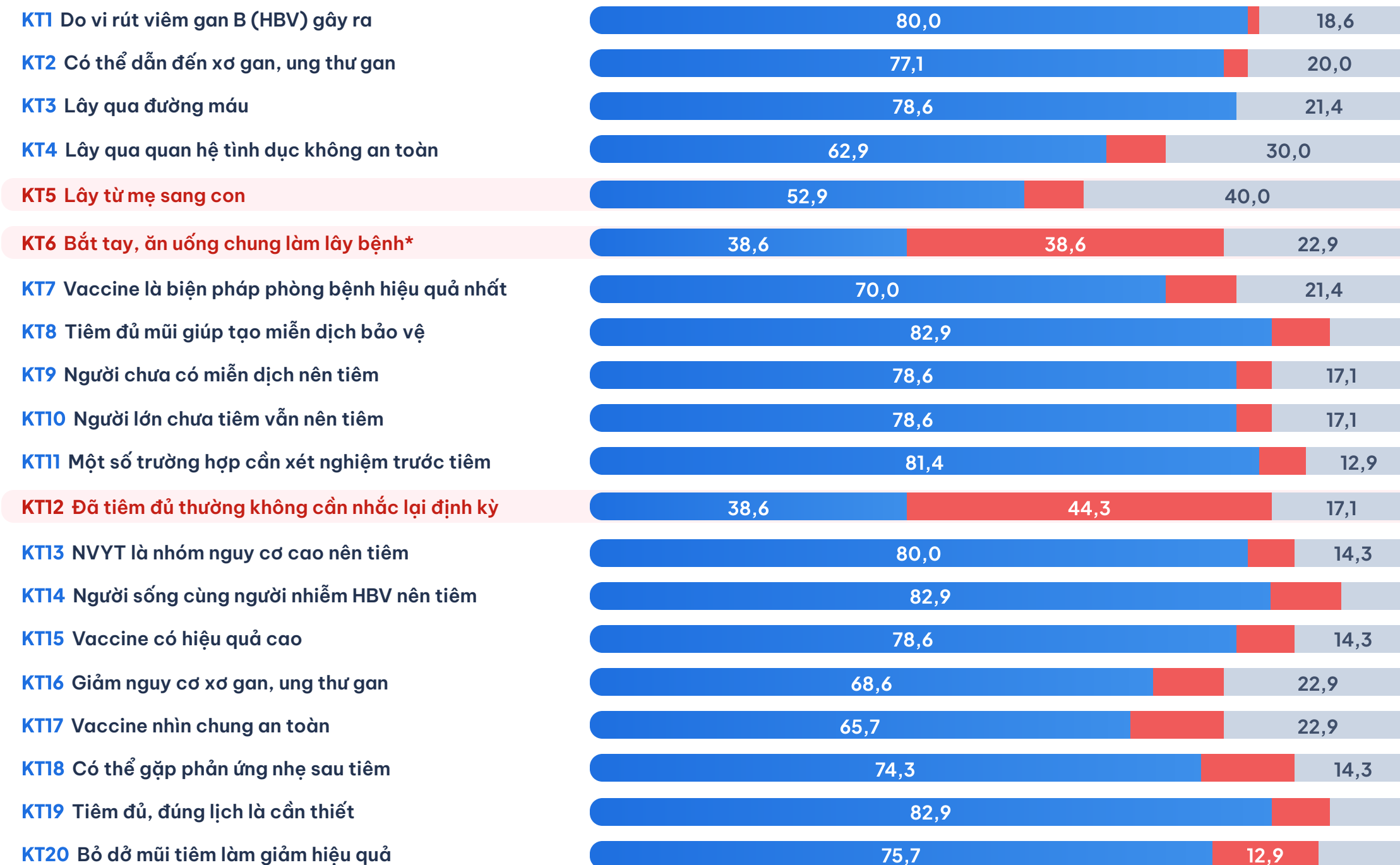
Nhưng **gần một nửa** chưa đạt chuẩn: truyền thông dự phòng ở người lớn vẫn còn nhiều **điểm khuyết**.



Bức tranh 20 câu hỏi kiến thức

■ Trả lời đúng ■ Trả lời sai ■ Không biết

Di chuột để xem nội dung đầy đủ



Hiểu tốt

- Căn nguyên vi rút: **80,0%**
- Lây qua máu: **78,6%**
- Tiêm đủ, đúng lịch: **82,9%**
- Biến chứng xơ gan/ung thư gan: **77,1%**



Hiểu sai / chưa biết

- KT5 lây mẹ → con: **47,1%** sai/không biết
- KT6 bắt tay, ăn uống chung: **61,4%** sai/không biết
- KT12 tiêm nhắc lại: **44,3%** trả lời sai



Nhấn △ **Điểm nhấn** để làm nổi ba câu cần ưu tiên tư vấn.

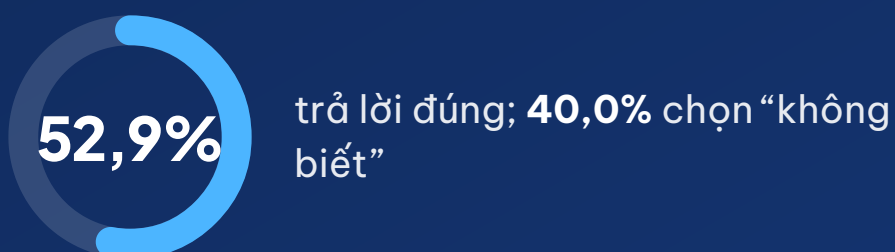


Ba “điểm nghẽn” kiến thức – đúng hay sai?

KT5 · Lây truyền mẹ → con

ĐÚNG

Lây truyền chu sinh là nguyên nhân chính của viêm gan B mạn tại Việt Nam.

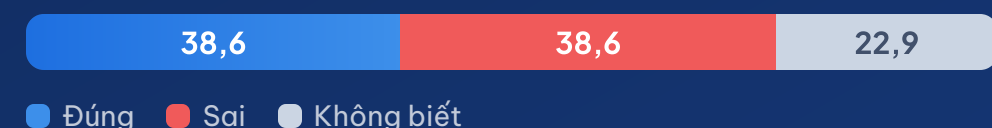
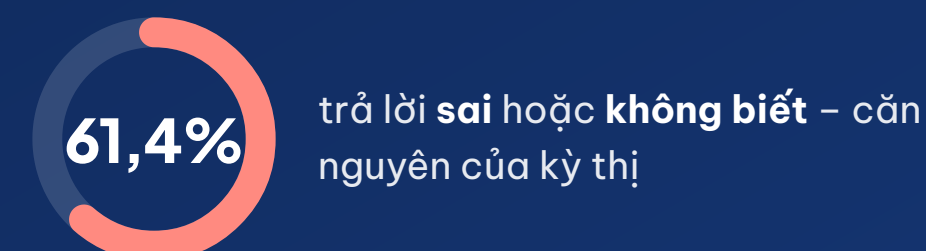


Tư vấn: tầm soát HBsAg khi mang thai; tiêm vaccine cho trẻ trong **24 giờ đầu** sau sinh.

KT6 · Tiếp xúc thông thường

SAI

HBV lây qua máu, quan hệ tình dục và mẹ – con; **không lây** qua ăn uống, bắt tay, sinh hoạt thông thường.

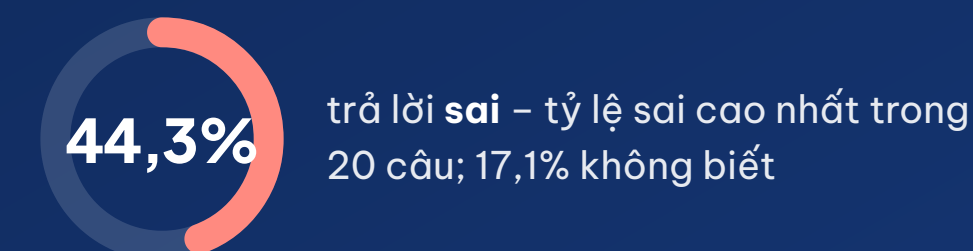


Tư vấn: khẳng định bệnh không lây qua ăn uống, sinh hoạt chung – sống chung an toàn, tránh kỳ thị.

KT12 · Tiêm nhắc lại

ĐÚNG

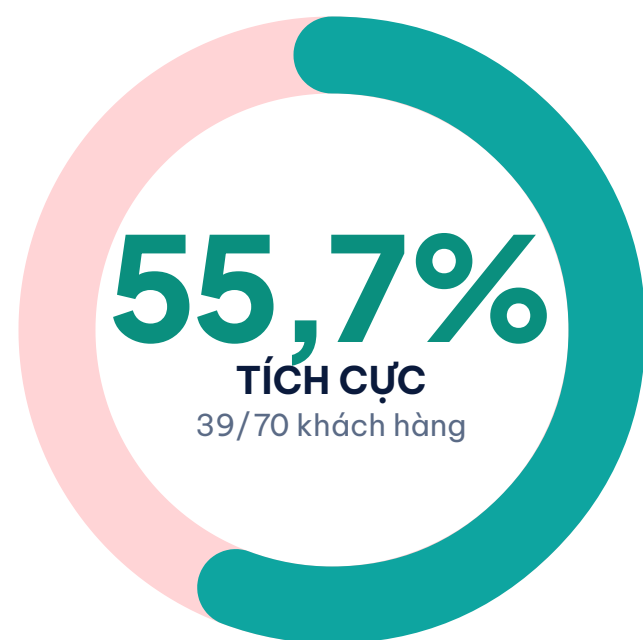
Không cần tiêm nhắc hằng năm như vaccine cúm; nên xét nghiệm định lượng **Anti-HBs** trước khi quyết định tiêm nhắc.



Tư vấn: xét nghiệm Anti-HBs trước khi tiêm nhắc; đủ kháng thể thì thường không cần tiêm nhắc định kỳ.



55,7% có thái độ tích cực với tiêm vaccine



Tích cực ($\geq 60/75$): 39 · 55,7%

Chưa tích cực: 31 · 44,3%

Điểm TB từng nội dung: 3,77 – 4,31 / 5

15 nội dung thái độ

■ Cao nhất ■ Các nội dung khác ■ Thấp nhất

TD15 Bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng

TD13 Làm theo khi bác sĩ/điều dưỡng tư vấn

TD12 Tin khuyến cáo của bác sĩ, NVYT

TD14 Chủ động tìm thông tin chính thống

TD2 Lo ngại gây xơ gan, ung thư gan

TD11 Sẵn sàng dành thời gian tiêm đủ mũi

TD9 Sẵn sàng tiêm nếu chưa tiêm/chưa đủ

TD10 Khuyến khích người thân, bạn bè tiêm

TD3 Vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả

TD4 Tiêm đúng lịch đạt hiệu quả tốt nhất

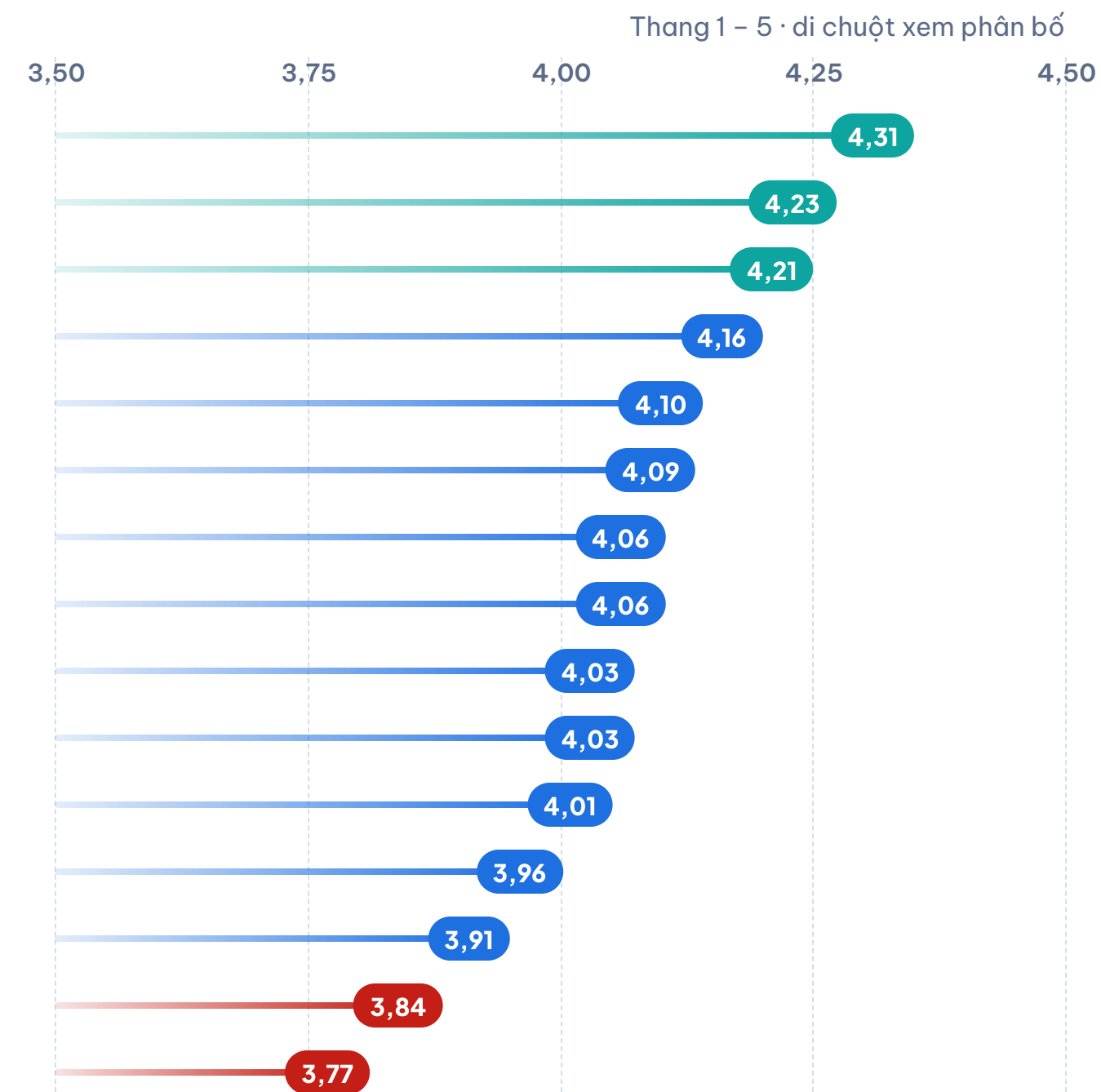
TD8 Tin chất lượng vaccine tại cơ sở cấp phép

TD1 Viêm gan B là bệnh nguy hiểm

TD5 Lợi ích lớn hơn nguy cơ phản ứng

TD7 Sẵn sàng tiêm dù có phản ứng nhẹ

TD6 Vaccine nhìn chung an toàn





Tin tưởng nhân viên y tế, nhưng còn e ngại an toàn



Điểm sáng

90,0%

tin tưởng khuyến cáo của NVYT
TD12 · điểm TB 4,21

87,1%

sẽ làm theo tư vấn của bác sĩ/
điều dưỡng
TD13 · 4,23

87,2%

tiêm để bảo vệ gia đình, cộng
đồng
TD15 · 4,31 – cao nhất



Rào cản cốt lõi

Lo ngại **an toàn** và **phản ứng sau tiêm** – điểm thấp nhất thang đo:

TD6 · Vaccine viêm gan B nhìn chung
an toàn

31,4% **phân vân / không đồng ý***

3,77

TD7 · Sẵn sàng tiêm dù có thể gặp
phản ứng nhẹ

28,6% **phân vân / không đồng ý***

3,84

Trùng khớp thang VAX của Ho NH (2026): nỗi sợ
biến cố bất lợi sau tiêm là nguyên nhân cốt lõi gây
ngập ngừng tiêm chủng.

* Tính từ Bảng 3.6; phần bàn luận của tiểu luận ghi gộp
“30,0% – 31,4%”.



Khoảng cách thái độ → hành động

80,0%



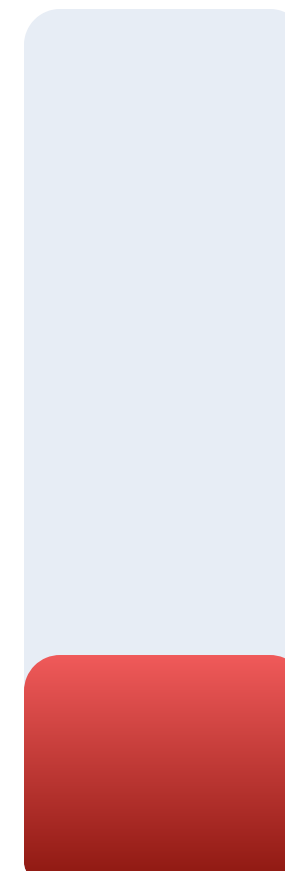
sẵn sàng tiêm nếu
chưa tiêm/chưa
đủ (TD9)

82,9%



sẵn sàng dành
thời gian tiêm đủ
mũi (TD11)

25,7%



thực tế đã tiêm
đủ phác đồ

Bận rộn, thiếu nhắc lịch, e ngại chi phí → cần **giải
pháp hỗ trợ hành động** (Kim TV 2024; Mengal HU).

TD9, TD11: đồng ý + hoàn toàn đồng ý, tính từ Bảng 3.6.



Yếu tố liên quan đến kiến thức

TIỀN SỬ & TIẾP CẬN

Được NVYT tư vấn vaccine < 0,001

Tiền sử tiêm vaccine < 0,001

Từng xét nghiệm HBV 0,003

Từng nghe/tìm hiểu về HBV 0,002

Người thân mắc HBV 0,012

Nhận tin từ người thân/bạn bè 0,043

NHÂN KHẨU HỌC

Trình độ học vấn 0,010

Nghề nghiệp 0,002

Thu nhập < 0,001

Giới tính 0,157

Tuổi 0,256

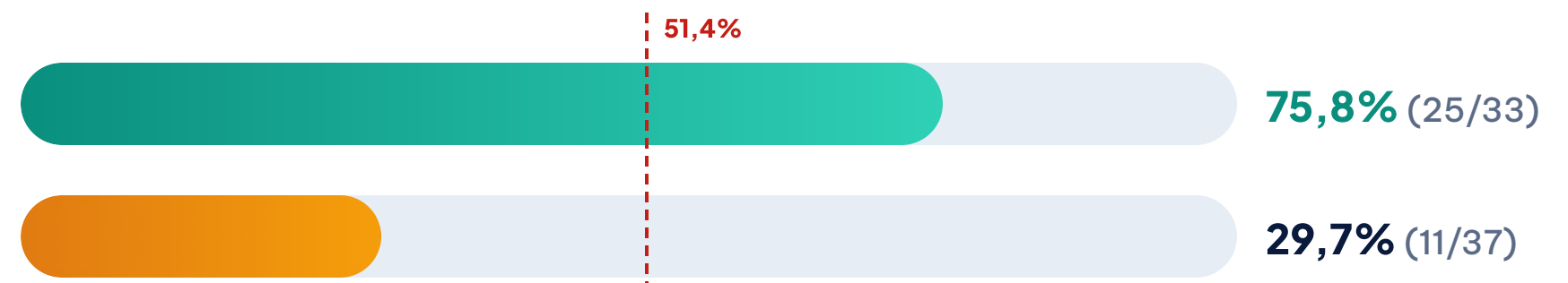
Tình trạng hôn nhân 0,098

Được NVYT tư vấn vaccine $p < 0,001$ ✓ có ý nghĩa thống kê

Tỷ lệ kiến thức đạt trong từng nhóm (%) · vạch đứt = tỷ lệ chung 51,4%

Đã từng

Chưa từng



💡 Được nhân viên y tế tư vấn: tỷ lệ đạt cao gấp hơn 2,5 lần (75,8% so với 29,7%).

p: kiểm định χ^2 / Fisher's exact cho toàn bộ các nhóm của yếu tố · N = 70.



Yếu tố liên quan đến thái độ tích cực

TIỀN SỬ & TIẾP CẬN

Người thân mắc HBV 0,001

Tiền sử tiêm vaccine 0,014

Được NVYT tư vấn vaccine 0,032

Các kênh thông tin 0,083 – 0,721

NHÂN KHẨU HỌC

Tình trạng hôn nhân 0,008

Nghề nghiệp 0,006

Thu nhập 0,021

Trình độ học vấn 0,189

Tuổi, giới tính > 0,05

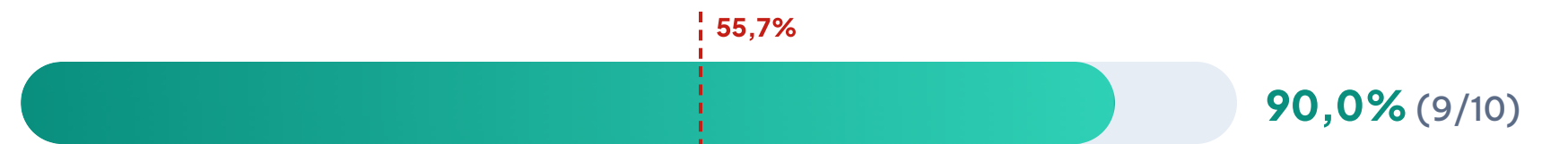
Người thân mắc HBV

p = 0,001

✓ có ý nghĩa thống kê

Tỷ lệ thái độ tích cực trong từng nhóm (%) · vạch đứt = tỷ lệ chung 55,7%

Có



Không

Không biết



Có người thân mắc bệnh: 90,0% có thái độ tích cực.

p: kiểm định χ^2 / Fisher's exact cho toàn bộ các nhóm của yếu tố · N = 70.



Bàn luận, điểm mới và hạn chế



So sánh với các nghiên cứu khác



Kiến thức đạt 51,4%



Tương đương **Quách Thị Cần** (Quảng Bình, 2017); cao hơn **Rajamoorthy** (Malaysia, 2019: 36,9%) và **Adjei** (Ghana, 2022: 29,6% kém) – do mặt bằng học vấn đô thị cao hơn.



Lỗi hồng mẹ – con và “ăn uống chung”



Tương đồng **Mesfin** (2018), **Pham TTH** (2019); nhầm lẫn đường lây giống **Adjei** (2022), **Trần Ánh Bắc** (2024) – nguy cơ bỏ lỡ mũi 24 giờ đầu và kỳ thị người bệnh.



Thái độ tích cực 55,7% – e ngại an toàn



Tương đồng **Ho NH** (TP.HCM, 2026: 65,6% sẵn sàng tiêm); lo ngại an toàn, phản ứng sau tiêm trùng thang **VAX** – biểu hiện của do dự vaccine.



Vai trò của tư vấn trực tiếp



Liên quan cả kiến thức (75,8% vs 29,7%) lẫn thái độ (69,7% vs 43,2%) – phù hợp **Kim TV** (2024), **Le Nguyen AT** (2019).



Điểm mới & tính ứng dụng

- ◆ Bảng chứng tại **phòng khám tư nhân đô thị** – nhóm chưa được khảo sát đầy đủ
- ◆ Chỉ ra **3 điểm nghẽn** kiến thức → tái cấu trúc nội dung tư vấn trước tiêm
- ◆ Khẳng định **tư vấn trực tiếp** là công cụ then chốt



Hạn chế

- ◆ Bảng hỏi **tự điền**: sai số hồi tưởng, tự báo cáo
- ◆ **N = 70**, chọn mẫu thuận tiện; một số ô có tần số kỳ vọng < 5
- ◆ Thiết kế **cắt ngang**: chưa xác lập quan hệ nhân quả
- ◆ **32,9%** không trả lời thu nhập

05

PHẦN NĂM

Kết luận và khuyến nghị



Thực trạng kiến thức & thái độ

Bản đồ yếu tố liên quan

Khuyến nghị

01
Đặt vấn đề

02
Tổng quan tài liệu

03
Đối tượng & phương pháp

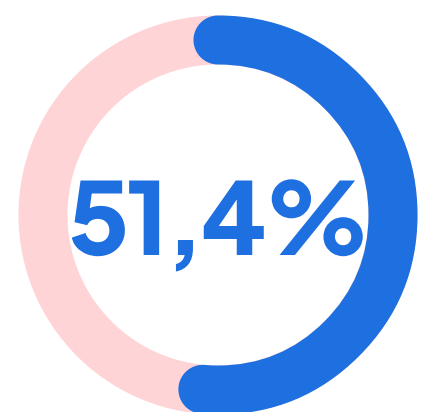
04
Kết quả & bàn luận

05
Kết luận & khuyến nghị

+
Dự phòng



Thực trạng kiến thức và thái độ



KIẾN THỨC

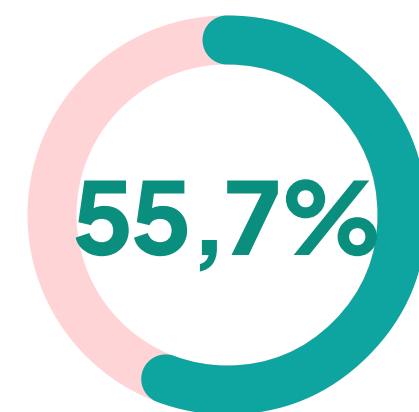
đạt (36/70)

Điểm TB 14,34 ± 4,49 / 20 · Min-Max 2-20

- Hiểu đúng căn nguyên (**80,0%**), biến chứng (**77,1%**), lây qua máu (**78,6%**), tiêm đủ phác đồ (**82,9%**).
- Khoảng trống:** mẹ → con chỉ **52,9%** đúng; **61,4%** sai/không biết về lây qua ăn uống, bắt tay; **44,3%** hiểu sai về tiêm nhắc lại.

TỶ LỆ TRẢ LỜI ĐÚNG Ở 3 ĐIỂM NGHẼN

KT5 · lây mẹ → con		52,9% (37/70)
KT6 · bắt tay, ăn uống chung		38,6% (27/70)
KT12 · tiêm nhắc lại		38,6% (27/70)



THÁI ĐỘ

tích cực (39/70)

Điểm TB từng nội dung 3,77 - 4,31 / 5

- Tin tưởng cao vào khuyến cáo NVYT (**4,21 - 4,23**) và ý thức bảo vệ cộng đồng (**4,31**).
- Rào cản lớn nhất:** e ngại an toàn, phản ứng sau tiêm (**3,77 - 3,84**). Sẵn sàng tiêm > 80% nhưng chỉ **25,7%** đã tiêm đủ liều.

TỪ THÁI ĐỘ ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Sẵn sàng tiêm (TD9)		80,0% (56/70)
Sẵn sàng tiêm đủ mũi (TD11)		82,9% (58/70)
Đã tiêm đủ mũi (Bảng 3.2)		25,7% (18/70)



Bản đồ các yếu tố liên quan

YẾU TỐ

ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC

Trình độ học vấn

KIẾN THỨC

● $p = 0,010$

THÁI ĐỘ

● $p = 0,189$

Nghề nghiệp

● $p = 0,002$

● $p = 0,006$

Thu nhập

● $p = < 0,001$

● $p = 0,021$

Tình trạng hôn nhân

● $p = 0,098$

● $p = 0,008$

Tuổi

● $p = 0,256$

● $p = > 0,05$

Giới tính

● $p = 0,157$

● $p = > 0,05$

TIỀN SỬ & TIẾP CẬN THÔNG TIN

Được nhân viên y tế tư vấn vaccine

● $p = < 0,001$

● $p = 0,032$

Tiền sử tiêm vaccine VGB

● $p = < 0,001$

● $p = 0,014$

Gia đình / người thân mắc HBV

● $p = 0,012$

● $p = 0,001$

Từng nghe / tìm hiểu về HBV

● $p = 0,002$

–

Từng xét nghiệm HBV

● $p = 0,003$

–

Nguồn tin người thân / bạn bè

● $p = 0,043 \downarrow$

● $p = 0,083$



THEN CHỐT

Được NVYT tư vấn: kiến thức đạt 75,8% vs 29,7%; thái độ tích cực 69,7% vs 43,2%.



TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

Đã tiêm đủ mũi (88,9% / 83,3%) và gia đình có người mắc (80,0% / 90,0%) là động lực củng cố nhận thức.



LƯU Ý

Nhận tin từ người thân, bạn bè: kiến thức đạt thấp hơn (41,9% vs 66,7%, $p = 0,043$).

● Có liên quan ($p < 0,05$) ● Không liên quan

Nhấn vào ô để xem chi tiết từng nhóm



05 KHUYẾN NGHỊ

Từ kết quả đến hành động



PKĐK MEDLATEC Tây Hồ & đội ngũ y bác sĩ



Tăng cường tư vấn trực tiếp của điều dưỡng trước và sau tiêm

Giải thích rõ tính an toàn sinh học của vaccine tái tổ hợp (không chứa vi rút sống), các phản ứng nhẹ thường gặp và cách tự theo dõi, xử trí tại nhà.

Tận dụng sự tin nhiệm cao dành cho NVYT để chỉ định sàng lọc và tư vấn tiêm HBV cho khách hàng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa khác.



Truyền thông giáo dục sức khỏe trúng đích 3 lỗ hồng kiến thức

Infographic, tờ rơi tại bàn khám, video ngắn ở màn hình chờ: (1) bệnh không lây qua ăn uống, sinh hoạt thông thường; (2) tầm soát lây mẹ – con và tiêm cho trẻ trong 24 giờ đầu; (3) xét nghiệm Anti-HBs trước khi tiêm nhắc, tránh lầm tưởng tiêm nhắc hằng năm.



Hoàn thiện hệ thống hỗ trợ hành động

Gửi SMS/Zalo ZNS hoặc thông báo qua ứng dụng MEDLATEC để nhắc lịch các mũi tiếp theo – chuyển thái độ “sẵn sàng” thành hành vi hoàn thành đủ phác đồ.



Khách hàng & cộng đồng



Chủ động tìm nguồn thông tin y tế chính thống

Tham vấn trực tiếp bác sĩ, điều dưỡng tại cơ sở y tế thay vì tin truyền miệng thiếu kiểm chứng từ người thân, bạn bè hoặc mạng xã hội.



Chủ động tầm soát và hoàn thành phác đồ

Người trưởng thành – nhất là nhóm chưa từng tiêm hoặc không rõ tiền sử – nên xét nghiệm HBsAg và Anti-HBs để được tư vấn tiêm đủ các mũi, tạo miễn dịch bền vững cho bản thân và gia đình.



Nghiên cứu tiếp theo



Mở rộng quy mô và đo thêm thực hành

Cỡ mẫu lớn hơn, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn; khảo sát thêm hành vi tiêm chủng thực tế (Practice) để đánh giá toàn diện mô hình KAP.

THÔNG ĐIỆP

Tư vấn trực tiếp của **điều dưỡng** là mắt xích chuyển **niềm tin** thành **mũi tiêm đủ phác đồ**.



Em xin trân trọng cảm ơn!

Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý Thầy, Cô trong Hội đồng
để tiểu luận được hoàn thiện hơn.

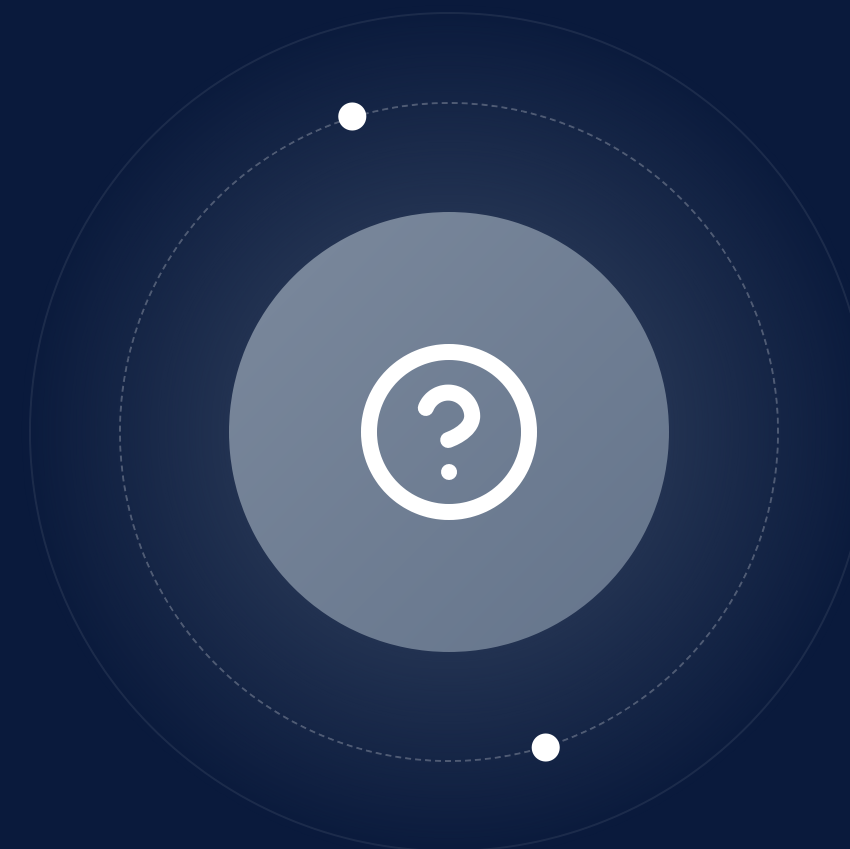
Sinh viên: Nguyễn Thị Hoài Nhi

Hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Phương Huy

Lớp TC23B2 · Khóa 2024 – 2026

 Hỏi – đáp

[Home](#) · [về trang bìa](#) · [○ tổng quan](#) · [→ slide dự phòng](#)



PHỤ LỤC TRÌNH CHIẾU

Slide dự phòng cho phần hỏi – đáp

Khái niệm nền tảng

Yếu tố liên quan theo y văn

Địa bàn nghiên cứu

Xử lý số liệu & đạo đức

Bảng 3.8

Bảng 3.9

Bảng 3.10

01
Đặt vấn đề

02
Tổng quan tài liệu

03
Đối tượng & phương pháp

04
Kết quả & bàn luận

05
Kết luận & khuyến nghị

+
Dự phòng



Các khái niệm nền tảng



Bệnh viêm gan B

Bệnh truyền nhiễm do **vi rút viêm gan B (HBV)** gây ra, có thể gây tổn thương gan cấp hoặc mạn tính.

Nhiễm HBV mạn → Xơ gan → Suy gan →

Ung thư gan

Trẻ sơ sinh nhiễm từ mẹ có nguy cơ chuyển mạn tính **rất cao**; ở người trưởng thành tỷ lệ này thấp hơn.



Vaccine phòng viêm gan B

- Vaccine **tái tổ hợp** chứa kháng nguyên bề mặt **HBsAg**
- Không chứa vi rút sống → **không thể gây nhiễm** HBV
- Bảo vệ **>95%** khi tiêm đủ, đúng lịch
- Trẻ sơ sinh: liều đầu **trong 24 giờ** sau sinh



Mô hình KAP

K

Kiến thức – hiểu biết về bệnh, đường lây, lợi ích, lịch tiêm, an toàn

A

Thái độ – niềm tin, quan điểm, mức sẵn sàng tiêm

P

Thực hành – ngoài phạm vi nghiên cứu này



Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ



Nhân khẩu học

Rajamoorthy (Malaysia, 764 hộ): chỉ **36,9%** có kiến thức tốt; nhóm 35–44 tuổi, học vấn và thu nhập cao hiểu biết tốt hơn.

Le Nguyen (Hà Nội, 807 phụ nữ): **80,8%** sẵn sàng tiêm; sẵn sàng chi trả liên quan nghề nghiệp, đặc điểm kinh tế – xã hội.



Kinh nghiệm & tiền sử tiêm chủng

Hwang (SV Mỹ gốc Việt): người từng **xét nghiệm, tiêm vaccine** hoặc có **người thân mắc HBV** có kiến thức cao hơn.

TP. HCM (284 người): hiểu đúng đường lây và mức độ nghiêm trọng → dễ bắt đầu tiêm liều đầu hơn.



Tư vấn & nguồn thông tin

Nhân viên y tế, người thân – bạn bè, internet, mạng xã hội, truyền hình, báo chí. **Tư vấn trực tiếp** từ NVYT giúp tiếp cận thông tin chính xác.

Chu JN (2017): trao đổi về HBV với gia đình/bạn bè, học vấn, tiền sử gia đình liên quan hiểu biết về đường lây.



Yếu tố liên quan thái độ

Ho NH (TP. HCM, 926 người, thang VAX): do dự, từ chối vaccine khác nhau theo đặc điểm xã hội – nhân khẩu, kiến thức, tình trạng tiêm chủng.

Kang (Hàn Quốc), **Wang** (Trung Quốc): kiến thức, niềm tin sức khỏe liên quan tỷ lệ tiêm.



Địa bàn: Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ



Trung tâm Tiêm chủng

thuộc Hệ thống Y tế MEDLATEC · hoạt động theo giấy phép của Sở Y tế Hà Nội

ISO 15189:2012

Hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế

CAP (Hoa Kỳ)

Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm của Hoa Kỳ

Dây chuyền lạnh GSP

Bảo quản vaccine đúng chuẩn

TT 34/2018 · QĐ 1575

Quy trình tiêm chủng an toàn: sàng lọc, tư vấn, theo dõi sau tiêm

HBsAg · Anti-HBs

Tầm soát nhiễm vi rút và định lượng kháng thể bảo vệ trước – sau tiêm; luôn sẵn vaccine tái tổ hợp đạt chuẩn

☆ Vì sao chọn địa bàn này?



Tính đại diện

Khách hàng đa dạng về **tuổi, nghề nghiệp, học vấn** – đại diện cho nhóm dân cư đô thị chủ động chăm sóc sức khỏe và sử dụng dịch vụ vaccine **tự nguyện**.



Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả là **căn cứ thực chứng** để điều dưỡng và nhân viên y tế nhận diện khoảng trống nhận thức, hoàn thiện nội dung tư vấn – giáo dục sức khỏe, nâng tỷ lệ tiêm HBV chủ động.



Xử lý số liệu và đạo đức nghiên cứu

BƯỚC 1

Kiểm tra, làm sạch, mã hóa phiếu

BƯỚC 2

Nhập liệu Microsoft Excel 2019

BƯỚC 3

Phân tích IBM SPSS Statistics 26.0

BƯỚC 4

Mô tả & kiểm định mối liên quan



Thống kê mô tả

Biến định tính: tần số (n), tỷ lệ (%).

Biến định lượng: **Mean ± SD**, Min – Max.



Kiểm định

Chi-square (χ^2) cho mối liên quan giữa biến độc lập với kiến thức, thái độ.

Không đủ điều kiện → **Fisher's exact** hoặc **Monte Carlo**. Ý nghĩa thống kê: **p < 0,05**.



Đạo đức nghiên cứu

- Được **BGH Trường ĐHY Hà Nội** và Ban lãnh đạo PKĐK đồng ý
- Tự nguyện, có quyền dừng bất kỳ lúc nào; thông tin bảo mật, chỉ dùng cho nghiên cứu
- Không can thiệp** vào khám sàng lọc, chỉ định và tiêm chủng

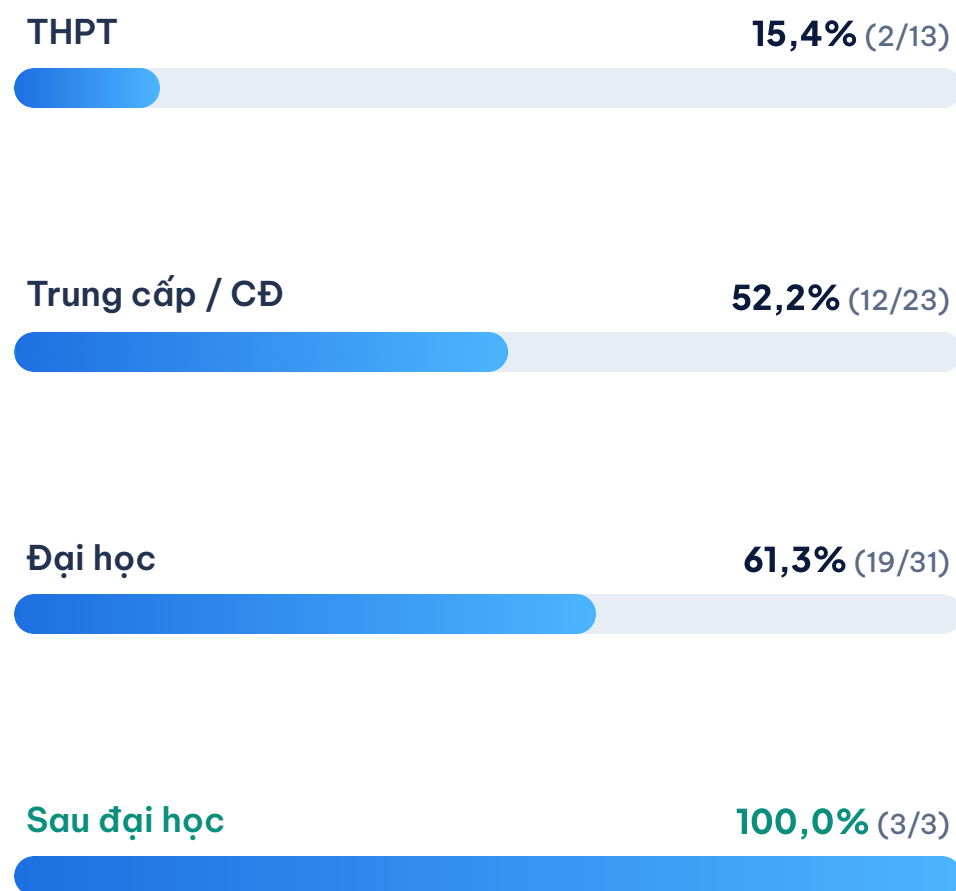


Kiến thức gắn với học vấn, nghề nghiệp, thu nhập

Học vấn

$p = 0,010$

Tỷ lệ kiến thức đạt (%)



Nghề nghiệp

$p = 0,002$

Tỷ lệ kiến thức đạt (%)



Thu nhập

$p < 0,001$

Tỷ lệ kiến thức đạt (%)



Không liên quan ($p > 0,05$): Tuổi · $p = 0,256$ Giới · $p = 0,157$ (nữ 59,0% vs nam 41,9%) Hôn nhân · $p = 0,098$

* Nhóm “Khác” 7/13 = 53,8% (bảng gốc ghi 43,8%)



Được tư vấn và đã tiêm đủ – kiến thức vượt trội



Từng nghe/tìm hiểu HBV

p = 0,002



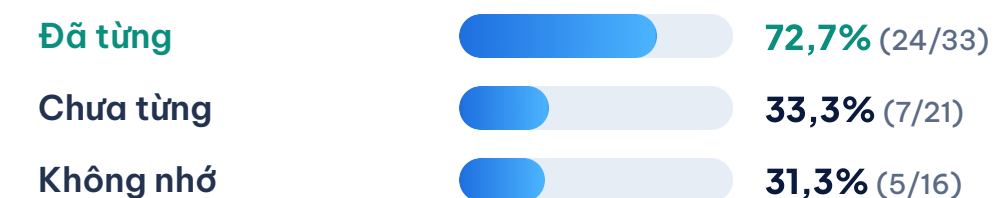
Được tư vấn vaccine

p < 0,001



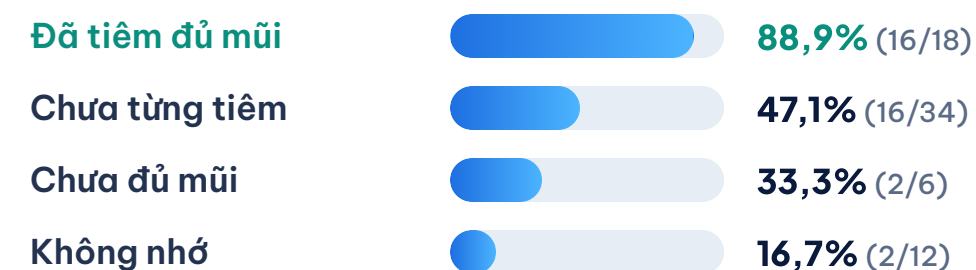
Từng xét nghiệm HBV

p = 0,003



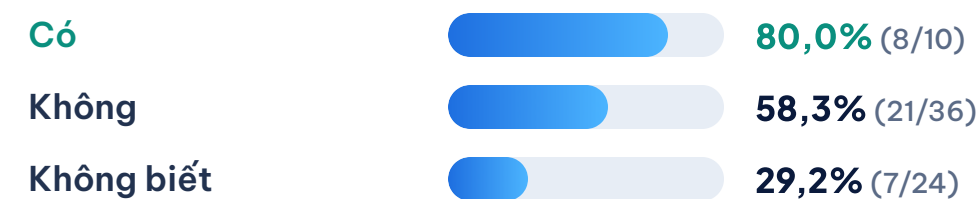
Tiền sử tiêm vaccine

p < 0,001



Gia đình mắc HBV

p = 0,012



Nguồn tin người thân/bạn bè

p = 0,043





Yếu tố liên quan đến thái độ tích cực



Tình trạng hôn nhân

p = 0,008



Nghề nghiệp*

p = 0,006



Thu nhập

p = 0,021



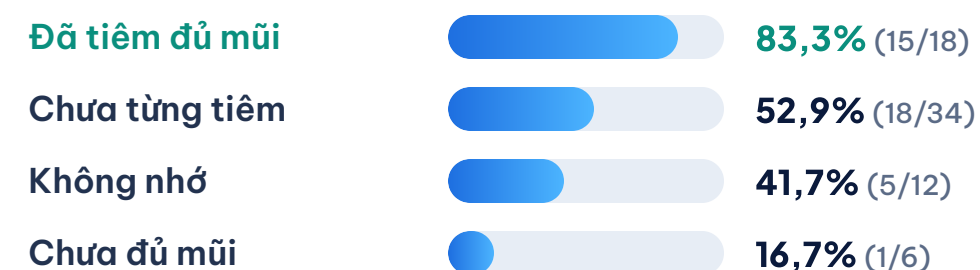
Được tư vấn vaccine

p = 0,032



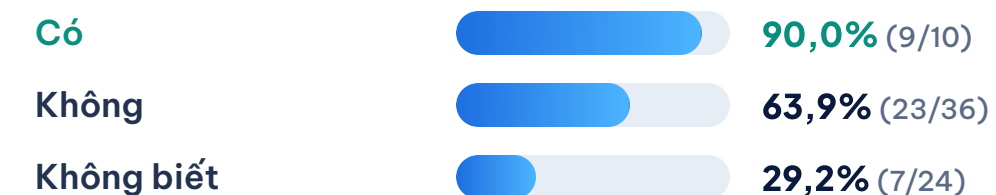
Tiền sử tiêm vaccine

p = 0,014



Gia đình mắc HBV

p = 0,001



Không liên quan ($p > 0,05$): Tuổi, giới Học vấn · p = 0,189 Mọi kênh thông tin · p = 0,083 – 0,721

* Không hiển thị nhóm nghề chỉ có 1 người (công nhân, kinh doanh, nghỉ hưu)